# GUÍA MAESTRA
# HMB

## Ensure Plus Advance y Glucerna Advance 1.6

Evidencia, segmentación, conversación clínica y selección de contenidos para el delegado

**ALCANCE**
Primera edición de la guía acumulativa. Integra 3 materiales: Glucerna CLM Gladiator Veeva, Glucerna Evidencia y ENSURE CLM Evidencia. Los dos materiales Glucerna contienen el mismo storyboard y se consolidan sin duplicar resultados. Se mantiene la trazabilidad por página del PDF.

**Fecha de corte:** 6 de noviembre de 2026

**Portfolio:** HMB

**Productos cubiertos:** Glucerna Advance 1.6, gama Glucerna HP/HC, Ensure Plus Advance y Ensure Plus Advance RTH

# Cómo usar esta guía

- Empieza por el perfil del paciente y la necesidad clínica, no por el producto.
- Usa el mapa de decisión para elegir Ensure o Glucerna.
- Selecciona un solo eje de evidencia por visita: supervivencia, músculo, función, desnutrición, control metabólico, adherencia o tolerancia.
- Comprueba siempre población, diseño, comparador, duración y limitaciones antes de verbalizar una cifra.
- Las páginas indicadas corresponden a la numeración del PDF, no a la diapositiva interna del storyboard.

**REGLA DE ORO**
Los resultados de programas multimodales que incluyen producto, consejo dietético y ejercicio deben describirse como resultados del programa, no como efecto aislado del producto. Los estudios observacionales muestran asociaciones y no prueban causalidad.

## Índice funcional


- 1. Mapa global del portfolio HMB
- 2. Glucerna Advance 1.6: ficha maestra
- 3. Evidencia Glucerna: Gladiator y López-Gómez
- 4. Ensure Plus Advance: ficha maestra
- 5. Evidencia Ensure: NOURISH, fractura de cadera, DRECO, inflamación y práctica real
- 6. Matriz de selección por perfil de HCP y paciente
- 7. Guiones de visita y preguntas de descubrimiento
- 8. Biblioteca de claims, requisitos y cautelas
- 9. Referencias y trazabilidad documental

# 1. Mapa global del portfolio HMB

| Situación clínica dominante | Opción prioritaria | Eje de conversación | Confirmar antes de mostrar |
|---|---|---|---|
| Diabetes/hiperglucemia + DRE o riesgo nutricional | Glucerna Advance 1.6 | Control metabólico + recuperación muscular y nutricional | MUST/GLIM, pérdida de peso, función, sarcopenia, tipo de diabetes, tratamiento |
| Diabetes + sarcopenia o deterioro funcional | Glucerna Advance 1.6 | Músculo, fuerza, función y estabilidad glucémica | Si el paciente está desnutrido/en riesgo; objetivo funcional y seguimiento |
| DRE sin diabetes como eje principal | Ensure Plus Advance | Supervivencia, recuperación nutricional, músculo y función | Edad, hospitalización, comorbilidad, inflamación, adherencia |
| Fractura de cadera en adulto mayor desnutrido | Ensure Plus Advance | Mortalidad a 6 meses y continuidad ≥3 meses | Carácter observacional; duración real de suplementación |
| EPOC/cardiopulmonar hospitalizado y desnutrido | Ensure Plus Advance | NOURISH: mortalidad, fuerza y postalta | Subgrupo/post hoc; protocolo al alta |
| Inflamación sistémica elevada | Ensure Plus Advance | HMB, inflamación y supervivencia sin reingreso | PCR, evidencia de abstract y análisis de subgrupo |
| Paciente oncológico con diabetes | Depende del eje | Glucerna si diabetes+DRE; Ensure si DRE/inflamación es dominante | Objetivo clínico prioritario y tolerancia |
| Nutrición enteral por sonda + diabetes | Gama Glucerna apropiada | Control glucémico, recuperación nutricional, tolerancia | Producto/formato exacto y pauta |
| Nutrición enteral por sonda + DRE general | Ensure Plus Advance RTH | Proteína, HMB, vitamina D, tolerancia e infecciones | Necesidades, volumen, función renal y protocolo local |

## Árbol rápido de decisión

- ¿Diabetes o hiperglucemia es una necesidad central? Si sí, evaluar Glucerna.
- ¿Existe DRE, riesgo nutricional o deterioro muscular? Si no, no forzar ninguno de los dos ejes.
- ¿La prioridad es supervivencia/postalta/fractura/EPOC/inflamación? Evaluar Ensure.
- ¿La prioridad es simultáneamente control glucémico y recuperación muscular? Evaluar Glucerna Advance 1.6.
- ¿Se requiere sonda? Confirmar formato RTH y requisitos del centro.

# 2. Glucerna Advance 1.6: ficha maestra

**Posicionamiento de los materiales:** SNO hiperproteico específico para diabetes destinado al paciente con diabetes/hiperglucemia y DRE o riesgo nutricional, con foco en control glucémico, salud muscular, función y recuperación nutricional.

## 2.1 Composición y características por 220 ml

| Elemento | Cantidad / descripción | Utilidad conversacional | Fuente |
|---|---|---|---|
| Energía | 355 kcal | Densidad energética en volumen reducido | Glucerna pp. 35-36 |
| Proteína | 18,3 g | Recuperación nutricional y muscular | pp. 35-36 |
| CaHMB | 0,77 g | Racional anabólico/anticatabólico y salud muscular | pp. 35-36 |
| Lisina | 2,2 g | Material la vincula con prevención de glicación proteica | pp. 35-36, 41 |
| Arginina | 1,3 g | Material la vincula con sensibilidad a insulina/vasodilatación | pp. 33, 35-36, 41 |
| Vitamina D | 7 µg | Componente de soporte musculoesquelético | pp. 35-36 |
| Fibra | 4,2 g | Mezcla de fibras | pp. 35-36 |
| Carbohidratos | Sistema de absorción lenta CarbSteady | Respuesta glucémica | pp. 31, 35-36 |
| Índice glucémico | 32 | Data on file, ISO 26642:2010 | pp. 35-36 |
| Administración | Válido por sonda según Nomenclátor citado, subtipo ESPEDH2 | Confirmar versión y protocolo institucional | p. 36 |

## 2.2 Racional clínico presentado

- Círculo músculo-nutrición-diabetes: resistencia a la insulina, disfunción mitocondrial, oxidación lipídica alterada, depósito graso, inflamación y deterioro muscular.
- Sarcopenia asociada en el material con mayor riesgo de hospitalización, nueva discapacidad en AVD y mortalidad tras el alta.
- HMB: racional anabólico, anticatabólico y antiinflamatorio. Parte del soporte mecanístico procede de jóvenes sanos, adultos mayores sanos, cultivos o modelos animales, por lo que no debe trasladarse literalmente a todos los pacientes.
- Arginina y lisina: soporte mecanístico para sensibilidad a insulina, síntesis proteica y glicación; distinguir evidencia de ingrediente de evidencia de fórmula completa.

## 2.3 Población de mayor afinidad

- Adultos con DM2 y alto riesgo de desnutrición o DRE.
- Pacientes con diabetes y sarcopenia, baja fuerza o deterioro funcional.
- Pacientes oncológicos con diabetes y desnutrición, reconociendo que el 60% de una cohorte RWE era oncológica.
- Pacientes al alta con diabetes y riesgo nutricional.
- Pacientes que precisan densidad energética, alta proteína y control de respuesta glucémica.

## 2.4 No convertir en recomendación automática

- Diabetes sin DRE ni riesgo nutricional demostrado.
- Uso por el mero hecho de una HbA1c alta, sin evaluar ingesta, peso, masa muscular y función.
- Pacientes pediátricos: los materiales aportados son de adultos.
- Atribuir reducción de complicaciones o mortalidad al producto cuando el material solo presenta asociaciones generales o evidencia de ingredientes.

# 3. Evidencia Glucerna: estudios y resultados

## 3.1 Estudio Gladiator

| Campo | Detalle |
|---|---|
| Diseño | Prospectivo, multicéntrico, evidencia de práctica real. |
| Población | 193 pacientes; edad media 69 años; 73% hombres; 100% con DM2 y alto riesgo de desnutrición; IMC medio 24,2 kg/m$^2$; HbA1c media 6,62%; 10 años de evolución; 87% con antidiabéticos orales y 23% con insulinoterapia. |
| Intervención | 90 días; recomendaciones dietéticas y de ejercicio adaptado; 2 envases diarios de Glucerna Advance 1.6. |
| Centros | 16 hospitales españoles más Hospital Clínico Universitario de Valladolid; incluye Virgen del Rocío, La Paz, La Fe, Reina Sofía y otros. |
| Fuente | García-Almeida JM et al., Diabetes 2026; referencia presentada como abstract con datos bibliográficos incompletos en el material. |
| Limitación central | Programa multimodal y fuente congresual/abstract. No aislar el efecto del producto. |

### Resultados comunicados en Gladiator

| Dominio | Resultado | Cómo decirlo correctamente | Páginas |
|---|---|---|---|
| Triglicéridos | -10%, de 136,5 a 123,5 mg/dL; p<0,001 | En el programa de 90 días se observó reducción frente a basal | 13-15 |
| Glucemia ayunas | -9,9 mg/dL; p=0,0199 | Mejora frente a basal dentro del programa | 13-14 |
| Masa celular corporal | +2 kg; p<0,0001 | Cambio frente a basal | 17-18 |
| Ángulo de fase | +0,5°; p<0,0001 | Cambio frente a basal; indicador de salud celular | 17-19 |
| Masa libre de grasa | +1,1 kg; p<0,0110 | Cambio frente a basal | 17-18 |
| Fuerza de prensión | +0,8 kg; p<0,049 | Cambio funcional frente a basal | 21-23 |
| Chair stand 30 s | +1,3 levantamientos; p<0,0001 | Mejora funcional frente a basal | 21-23 |
| Sarcopenia | -26% de pacientes clasificados con sarcopenia | Resultado a 90 días dentro del programa | 21-22 |
| Riesgo nutricional | 65% mejoró su clasificación | Especificar criterio y programa multimodal | 24-25 |
| Estado nutricional | 6 de cada 10 mejoraron según GLIM; otra lámina indica 50% | Existe inconsistencia entre láminas: no verbalizar sin confirmar versión final | 24-27 |
| Vitamina D | 32% de incremento; 22,69 a 29,98; p<0,0001 | Cambio frente a basal | 24-25 |
| Calidad de vida/distrés | Mejora de calidad de vida y reducción del distrés; p<0,01 y p<0,001 | Usar solo con instrumentos y dirección confirmados en material final | 28-30 |
| Confianza profesional | 70% concluye que ayuda a objetivos marcados | Resultado de percepción; no equiparar a outcome clínico | 28-29 |

## 3.2 López-Gómez et al., Nutrients 2025;17:3208

| Campo | Detalle |
|---|---|
| Diseño | Observacional comparativo, prospectivo, práctica real; alta hospitalaria. |
| Población | 95 pacientes; edad media 71 años; 51% hombres; 82% desnutridos; IMC 24,01 kg/m$^2$; 34,7% con sarcopenia; 60% oncológicos; 83% DM2, 7% DM1, 8% DM3c, 2% monogénica; 36% con insulina. |
| Cohortes | 44 con SNO hiperproteico específico para diabetes con HMB; 53 con SNO específico para diabetes sin HMB. |
| Duración | 3 meses. |
| Limitaciones | No aleatorizado; potencial confusión por indicación y diferencias basales; elevada proporción oncológica; asociación, no causalidad. |

| Outcome | Resultado comunicado | Comparador / matiz | Páginas |
|---|---|---|---|
| HbA1c | +0,15% con HMB vs +0,98% sin HMB; descrito como 6,5 veces mayor estabilidad | Cambio relativo frente a basal; no equivale a reducción absoluta de HbA1c | 16 |
| Grosor recto femoral | +9,17% con HMB vs -6,30% sin HMB; p<0,01 | Análisis multivariante; odds de mejora 9,3 veces | 17-20 |
| Área muscular | +5,84% con HMB vs -9,34% sin HMB; p<0,01 | Ultrasonido; análisis multivariante | 11, 18 |
| Adherencia | 91% consumió ≥75% de la pauta recomendada | Población RWE, 60% oncológica | 35-36, 41 |

**MENSAJE OPERATIVO GLUCERNA**

La visita debe unir tres problemas: desnutrición, diabetes y músculo. El delegado debe descubrir cuál domina en la práctica del HCP y mostrar solo el resultado que responda a esa prioridad.

# 4. Ensure Plus Advance: ficha maestra

**Posicionamiento en los materiales:** SNO hipercalórico e hiperproteico con CaHMB para DRE, orientado a preservar/recuperar músculo, función y estado nutricional, con evidencia en resultados clínicos de pacientes complejos.

## 4.1 Composición por botella de 220 ml

| Elemento | Cantidad | Uso conversacional | Páginas |
|---|---|---|---|
| Energía | 330 kcal | Aporte concentrado | 33-34 |
| Proteína | 20 g | Recuperación nutricional/muscular | 33-34 |
| CaHMB | 1,5 g | Racional anabólico, anticatabólico y antiinflamatorio | 26-27, 33-37 |
| FOS | 3,08 g | Fibra/prebiótico según composición | 33-34 |
| Vitamina D | 13 µg | Función muscular/movilidad en el marco del material | 33-34 |
| Micronutrientes | 27 vitaminas y minerales | Completitud nutricional | 33-34 |
| Sabores | Hasta 5 | Adaptación a preferencias y adherencia | 33-34 |
| Adherencia | Hasta 93% | Estudio RWE de 50 pacientes | 33-34 |

## 4.2 Pauta comunicada de 2 botellas/día

- 40,04 g de proteína de alta calidad.
- 3 g de CaHMB.
- 1.000 UI de vitamina D.
- El material vincula esta combinación con salud muscular, inflamación y mortalidad, pero cada claim procede de diseños y poblaciones distintas.

## 4.3 Ensure Plus Advance RTH 500 ml

| Elemento por 500 ml | Cantidad / descripción |
|---|---|
| Proteína | 40 g |
| CaHMB | 1,5 g CaHMB equivalente a 1,2 g HMB según nota del material |
| FOS | 6 g |
| Administración | Válido por sonda según Nomenclátor citado, subtipo CPHH2, julio 2026 |

**Pauta presentada:** 2 botellas/día: 80 g proteína, 3 g CaHMB y 25 µg vitamina D.

**Claims RTH en material:** Preservación muscular; mejor tolerancia gastrointestinal y reducción de infecciones frente a otras fórmulas enterales hiperproteicas, basado en Cereda et al. 2023. Revisar comparador y población antes de usar.

## 4.4 Territorios clínicos representados

- Patología cardíaca y pulmonar, EPOC y bronquiectasias.
- Cáncer.
- Fractura de cadera y ortogeriatría.
- Cirugía y hospitalización.
- Paciente pluripatológico, prefragilidad y adultos mayores.
- COVID-19/UCI, cirrosis y enfermedades con inflamación.
- Malabsorción, neurología crónica y enfermedad cardiopulmonar crónica en práctica ambulatoria.

# 5. Evidencia Ensure: estudios clave

## 5.1 NOURISH

| Campo | Detalle |
|---|---|
| Diseño | ECA multicéntrico, prospectivo, doble ciego, grupos paralelos. |
| Población | 652 adultos >65 años, hospitalizados, con desnutrición moderada o grave. |
| Objetivo | Efecto de un SNO hiperproteico con HMB en pacientes mayores desnutridos hospitalizados. |
| Intervención | En subanálisis: 2 botellas/día de fórmula equivalente a Ensure Plus Advance durante 90 días tras el alta. |
| Resultados destacados por el material | Mortalidad, recuperación del estado nutricional y función muscular. |
| Limitación de comunicación | Algunos resultados proceden de análisis post hoc y subgrupos. Debe nombrarse el subgrupo exacto. |

| Subgrupo/outcome | Resultado del material | Cómo utilizarlo | Páginas |
|---|---|---|---|
| EPOC n=214 | Reducción del 71% en mortalidad; tasas significativamente menores a 30, 60 y 90 días | Presentar como análisis post hoc de cohorte EPOC, no como resultado primario global | 19-23, 32 |
| Cardiopulmonar n=180 | Mejora de fuerza de prensión durante 90 días | Cohorte apareada/adherencia >6 semanas; explicar diseño | 20, 22 |
| Recuperación nutricional | Mejora del estado nutricional | No mezclar con RWE ambulatorio; revisar pie específico | 19-23 |

## 5.2 Fractura de cadera

| Campo | Detalle |
|---|---|
| Diseño | Cohorte prospectiva observacional, práctica real, comparativa HMB vs no HMB. |
| Muestra | 107 adultos ≥65 años con desnutrición y fractura de cadera. |
| Resultado | Mortalidad a 6 meses: 13,6% con HMB vs 35,4% sin HMB; p=0,011. HR ajustada 0,358; IC95% 0,145-0,885; p=0,026. Reducción relativa comunicada: 64%. |
| Duración | Los tratados con fórmula con HMB durante ≥3 meses registraron 0% de mortalidad en el material. |
| Cautela | Observacional; adherencia/duración pueden reflejar supervivencia y selección. Hablar de asociación. |
| Fuente | Sánchez-Torralvo et al., Nutrients, referencia mostrada en el material como 2026;16(2):217, con posibles inconsistencias bibliográficas que conviene verificar. |

## 5.3 Subanálisis morfofuncional DRECO

| Campo | Detalle |
|---|---|
| Población | 461 pacientes hospitalizados: HMB n=263 y control n=198; 88% con desnutrición GLIM; 47% desnutrición grave. |
| Resultado | 59% menos riesgo de mortalidad a 6 meses frente a SNO sin HMB; HR 0,41; IC95% 0,17-0,99; p=0,048, ajustado por edad, sexo, IMC y GLIM. |
| Fuente | Abstract ESPEN 2026, García-Almeida JMN et al. |
| Cautela | Evidencia congresual no equivalente a publicación completa; observacional/subanálisis. |

## 5.4 Inflamación elevada y cardiopulmonar

| Población / fuente | Resultado comunicado | Cautela |
|---|---|---|
| Mayores hospitalizados, PCR >100 mg/L; abstract ESPEN26-ABS-1706 | 6,1 veces más probabilidad de supervivencia sin reingreso a 90 días; 74% menos probabilidad de reingreso; 4,1 veces más probabilidad de mejorar fuerza de prensión a 30 días | Abstract; subgrupo; confirmar denominadores y modelo antes de usar |
| Revisión retrospectiva n=283, 63% cáncer | Reducción del 68% en ratio PCR/prealbúmina, de 0,25 a 0,08 | La diferencia frente a SNO estándar no fue significativa según nota del propio material |
| Mecanismo HMB | Modulación NF-κB y citoquinas, menor inflamación y mejor salud muscular | Parte de cultivos celulares y animales; usar como racional, no outcome clínico |

## 5.5 Práctica real ambulatoria, de Luis et al. JCSM 2025

| Campo | Detalle |
|---|---|

| Campo | Detalle |
|---|---|
| Diseño/población | 50 pacientes ambulatorios desnutridos con malabsorción, oncología no terminal, neurología crónica o enfermedad cardiopulmonar crónica. |
| Intervención | 2 porciones diarias de Ensure Plus Advance durante 3 meses dentro de atención estándar. |
| Adherencia | 93% comunicada. |
| Limitación | Estudio pequeño, sin comparador explícito en las láminas; varios outcomes frente a basal. |

| Outcome | Cambio |
|---|---|
| Índice músculo esquelético | +5,1% |
| Masa músculo esquelético | +3,1% |
| Masa libre de grasa | +2,7% |
| Fuerza de prensión | +6,1%; p=0,01 |
| Timed Up and Go | Mejora 8,6%; p=0,04 |
| Proporción de músculo | Casi +6,5% |
| Índice de grosor muscular ajustado por altura | +10,8% |
| Grosor vasto intermedio | +9,0% |

# 6. Matriz HCP, necesidad y evidencia

| HCP / unidad | Necesidad a explorar | Producto/evidencia inicial | Pregunta de descubrimiento | No asumir |
|---|---|---|---|---|
| Endocrinología | DM + pérdida de peso/músculo | Glucerna: Gladiator y López-Gómez | ¿Cómo identifica al paciente diabético que mantiene HbA1c aceptable pero pierde fuerza o masa muscular? | Que todo paciente con DM necesita SNO |
| Nutrición clínica | DRE + DM o hiperglucemia | Glucerna: GLIM, músculo y HbA1c | ¿Qué outcome prioriza tras el alta: peso, GLIM, ecografía, fuerza o control glucémico? | Que un solo marcador define recuperación |
| Geriatría/Ortogeriatría | Fractura + DRE | Ensure: cohorte fractura de cadera | ¿Durante cuánto tiempo mantienen el SNO después del alta y cómo monitorizan adherencia? | Causalidad de mortalidad |
| Medicina Interna | Paciente pluripatológico hospitalizado | Ensure: NOURISH/DRECO | ¿Qué pacientes salen del hospital con un plan nutricional de 90 días? | Generalizar subgrupos |
| Neumología | EPOC y DRE | Ensure: subanálisis NOURISH EPOC | ¿La fuerza de prensión forma parte del seguimiento postalta? | Que el resultado global sea específico de EPOC |
| Oncología | DRE, inflamación, músculo; con/sin DM | Ensure o Glucerna según diabetes | ¿Qué condiciona más la elección: control glucémico, inflamación, tolerancia o función? | Que ser oncológico define producto |
| Rehabilitación | Fuerza y función | Ensure RWE / Glucerna Gladiator según DM | ¿Qué cambio funcional considera clínicamente útil en 90 días? | Equiparar asociación con reducción de caídas |
| Cirugía | Riesgo nutricional peri/postoperatorio | Ensure, evidencia hospitalaria | ¿Cómo se asegura la continuidad nutricional durante 90 días? | Usar evidencia fuera de población |
| Farmacia hospitalaria | Valor, pauta y trazabilidad | Ficha de composición + estudio relevante | ¿Qué outcomes y qué nivel de evidencia exige el protocolo del centro? | Que claims comerciales sustituyen evaluación |
| Enfermería/Dietista | Adherencia y tolerancia | Ensure 5 sabores/93%; Glucerna 91% ≥75% pauta | ¿Qué barreras reales limitan completar la pauta? | Que variedad garantiza adherencia |

# 7. Guiones de visita para el delegado

## 7.1 Visita Glucerna, 5 minutos

**Apertura:** "En los pacientes con diabetes y riesgo nutricional, ¿qué le preocupa más: mantener el control glucémico o recuperar músculo y funcionalidad sin desestabilizarlo?"

**Descubrimiento:** Preguntar por MUST/GLIM, pérdida de peso, sarcopenia, fuerza, ecografía muscular, proporción oncológica, pauta al alta y adherencia.

**Puente:** "Tenemos evidencia de práctica real específica en pacientes con diabetes y desnutrición que integra resultados metabólicos, musculares y funcionales durante 90 días."

**Contenido a mostrar:** Elegir uno: HbA1c y triglicéridos; grosor muscular; fuerza/Chair Stand; recuperación GLIM; adherencia.

**Cierre:** "¿En qué perfil de sus pacientes tendría más sentido evaluar conjuntamente control glucémico y recuperación muscular?"

## 7.2 Visita Ensure, 5 minutos

**Apertura:** "Tras el alta, ¿qué pacientes desnutridos considera que mantienen mayor riesgo: los de baja fuerza, inflamación elevada o los que no sostienen la pauta nutricional?"

**Descubrimiento:** Preguntar por GLIM, PCR, fuerza de prensión, diagnóstico de ingreso, reingreso, mortalidad, continuidad 90 días y seguimiento funcional.

**Puente:** "La evidencia con SNO hiperproteico con HMB aborda desde recuperación muscular hasta resultados postalta en poblaciones concretas."

**Contenido a mostrar:** Elegir un escenario: NOURISH/EPOC; fractura de cadera; DRECO; inflamación; RWE ambulatorio; RTH.

**Cierre:** "¿Qué resultado tendría más peso para incorporar o mantener un plan nutricional durante tres meses?"

## 7.3 Banco de preguntas clínicas

- ¿Qué herramienta de cribado utiliza y en qué momento del circuito?
- ¿Qué le hace considerar fracaso del plan nutricional: peso, ingesta, fuerza, función o reingreso?
- ¿Cuándo mide fuerza de prensión o utiliza ecografía muscular?
- ¿Qué barrera limita más la adherencia: volumen, sabor, tolerancia, cansancio o ausencia de seguimiento?
- ¿Qué duración mínima considera necesaria para valorar recuperación?
- ¿Qué pacientes con diabetes quedan infradiagnosticados de DRE por tener IMC normal?
- ¿Cómo cambia su elección cuando coexisten diabetes y cáncer?
- ¿Utiliza PCR o un marcador inflamatorio para estratificar el riesgo?
- ¿Quién es responsable de revisar la pauta tras el alta?
- ¿Qué dato clínico necesitaría para cambiar el protocolo local?

# 8. Biblioteca de claims, requisitos y cautelas

| Mensaje del material | Producto | Requisito que debe acompañarlo | Riesgo de mala comunicación |
|---|---|---|---|
| Mejora control metabólico en 90 días | Glucerna | Programa con dieta y ejercicio; frente a basal | Atribuir todo al producto |
| Mayor estabilidad de HbA1c | Glucerna | RWE comparativo; 60% oncológicos | Decir que reduce HbA1c |
| 9,3 veces más probabilidad de aumentar grosor muscular | Glucerna | Análisis multivariante RWE y comparador sin HMB | Generalizar a todos los diabéticos |
| Mejora función y reduce sarcopenia | Glucerna | Gladiator, programa multimodal | Prometer prevención de discapacidad |
| Reduce mortalidad 71% | Ensure | Subgrupo EPOC, análisis post hoc NOURISH | Presentarlo como outcome global o causal |
| Reduce riesgo de mortalidad 64% | Ensure | Cohorte observacional fractura de cadera | Omitir diseño observacional |
| 59% menos riesgo de mortalidad | Ensure | Abstract DRECO, ajustado, hospitalizados | Presentar abstract como evidencia definitiva |
| 6,1 veces supervivencia sin reingreso | Ensure | PCR >100 mg/L, abstract cardiopulmonar | Generalizar a cualquier inflamación |
| Reduce inflamación 68% | Ensure | Revisión retrospectiva; diferencia vs estándar no significativa | Afirmar superioridad |
| 93% adherencia | Ensure | RWE n=50; pauta y definición concretas | Prometer adherencia universal |
| 91% consume ≥75% de pauta | Glucerna | RWE, 60% oncológica | Comparar directamente con Ensure |

## 8.1 Inconsistencias o puntos a verificar

- Gladiator aparece como Diabetes 2026;XX(Supplement_X):XXXX-LB, por lo que faltan datos bibliográficos finales.
- El resultado nutricional de Gladiator aparece como 6 de cada 10 y también como 50% en distintas láminas. Confirmar la versión aprobada antes de utilizar cifra.
- La referencia Sánchez-Torralvo se muestra con año/volumen potencialmente inconsistente en distintas partes del material.
- En Ensure, varias cifras 2026 proceden de abstracts ESPEN y deben etiquetarse como evidencia congresual.
- Las comparaciones de ingrediente HMB/leucina incluyen evidencia mecanística o en sanos, no siempre evidencia directa de la fórmula o de pacientes con DRE.
- La lámina comparativa de competidores se extrajo de forma incompleta y no se incorpora como tabla usable hasta disponer de lectura visual o documento fuente legible.

## 8.2 Qué debe registrar el delegado en CRM

- Tipo de paciente prioritario y volumen aproximado.
- Herramienta de cribado y criterio diagnóstico nutricional.
- Outcome que más valora el HCP.
- Duración habitual y pauta del soporte.
- Barreras de adherencia/tolerancia.
- Lugar del circuito donde se pierde continuidad.
- Evidencia presentada y reacción concreta.
- Pregunta pendiente y siguiente paso acordado.

# 9. Referencias y trazabilidad documental

## 9.1 Documentos fuente

| Documento | Páginas | Contenido principal | Tratamiento |
|---|---|---|---|
| Glucerna CLM Gladiator Veeva-4zv4b.pdf | 48 | Storyboard completo Glucerna Advance 1.6, estudios, composición y gama | Fuente principal Glucerna |
| Glucerna Evidencia.pdf | 48 | Contenido sustancialmente idéntico al anterior | Duplicado consolidado, no suma evidencia |
| ENSURE - CLM Evidencia 2ftd.pdf | 46 | Ensure Plus Advance, NOURISH, fractura, DRECO, inflamación, RWE y RTH | Fuente principal Ensure |

## 9.2 Bibliografía prioritaria del material Glucerna


- García-Almeida JM et al. Diabetes 2026; abstract Gladiator, datos incompletos en material.
- López-Gómez JJ et al. Nutrients. 2025;17(20):3208.
- Matía Martín P et al. Clin Nutr. 2019;38(3):1253-1261.
- Sanz-París A et al. Clin Nutr. 2020;39(11):3273-3282.
- De Luis Román D et al. Clin Nutr Open Sci. 2022;44:107-117.
- Barazzoni R et al. Clin Nutr. 2025;55:208-218.


## 9.3 Bibliografía prioritaria del material Ensure


- Deutz NE et al. Clin Nutr. 2016;35(1):18-26. Estudio NOURISH.
- Deutz NE et al. Clin Nutr. 2021;40(3):1388-1395.
- De Luis D et al. J Cachexia Sarcopenia Muscle. 2025;16:e13700.
- Sánchez-Torralvo et al. Nutrients; referencia indicada en el material.
- Cornejo-Pareja I et al. Nutrients. 2021;13(12):4355.
- Cereda E et al. Nutrition. 2023;26:111901.
- García-Almeida JMN et al. ESPEN 2026 abstract, DRECO.
- Guzmán Rolo G et al. ESPEN 2026 abstract ESPEN26-ABS-1706.


**ESTADO DE LA GUÍA**
Esta es la primera versión detallada del repositorio HMB. Cada nuevo documento se integrará por producto, población, composición, estudios, outcomes, claims, páginas y reglas de recomendación. Cuando exista contradicción, prevalecerá el material aprobado más reciente y se conservará la discrepancia para revisión.

# PARTE II. Portfolio ESP

**ALCANCE DE ESTA ACTUALIZACIÓN**
Se incorporan PediaSure Plus Fiber, PediaSure Peptide, Vital Peptido 1.5, Similac High Energy y la gama Nepro. La información procede de los tres nuevos materiales proporcionados y conserva cifras, población, comparadores, páginas y cautelas.

## 10. Mapa global ESP

| Paciente / necesidad | Producto a explorar | Eje principal | Confirmar antes de presentar |
|---|---|---|---|
| Niño con desnutrición y síntomas GI con tolerancia a proteína entera | PediaSure Plus Fiber | Crecimiento, apetito, fibra y síntomas GI | Edad, patrón de síntomas, estreñimiento, vía oral/sonda, tolerancia |
| Niño con función GI comprometida o intolerancia a fórmula polimérica | PediaSure Peptide | Péptidos, 50% MCT, baja osmolaridad y tolerancia | Motivo de intolerancia, proteína hidrolizada, densidad requerida, fibra |
| Paciente con mayor requerimiento proteico/energético y necesidad peptídica | Vital Peptido 1.5 | 13 g proteína, 70% MCT, 1,5 kcal/ml y aceptación | Edad/población concreta, indicación autorizada y necesidad de fibra |
| Lactante con altas necesidades energéticas | Similac High Energy | 1 kcal/ml, tolerancia, azúcar/osmolaridad bajas, sin aceite de palma | Edad gestacional, cardiopatía, prematuridad, crecimiento y lactancia materna |
| ERC 3-5 no dializado | Nepro Gold LP | HC, hipoproteico, ratio fósforo/proteína y fibra | FG, estadio, DPE, ingesta y prescripción proteica |
| Hemodiálisis o diálisis peritoneal | Nepro Gold HP / Nepro HP 500 ml | HC/alto en proteína, fibra y recuperación nutricional | Modalidad de diálisis, ingesta, potasio/fósforo, volumen y tolerancia |
| ERC 1-2 hospitalizado / LRA 2 con DRE | SNO HC/HP con HMB según algoritmo | Energía, proteína y DRE | Situación basal renal, catabolismo y necesidades individualizadas |

# 11. PediaSure Plus Fiber

**Territorio clínico:** Niños con desnutrición y síntomas gastrointestinales, cuando se busca soporte del crecimiento con fórmula polimérica, fibra soluble/insoluble y MCT.

## 11.1 Composición y formato

| Elemento por 220 ml | Dato | Uso práctico |
|---|---|---|
| Proteína | 9,24 g; 11,07% del valor calórico total | Soporte de masa magra y crecimiento |
| Fibra | 2,42 g; mezcla soluble:insoluble aproximada 49:51 | Explorar estreñimiento, diarrea y patrón GI |
| MCT | 19,78% de la grasa | Racional de absorción rápida de nutrientes |
| Densidad | 1,5 kcal/ml visible en envase | Aporte concentrado |
| Formatos | 30 botellas de 220 ml; vainilla, fresa, plátano, chocolate y multisabor | Chocolate indicado a partir de 3 años; multisabor 18 vainilla, 6 fresa y 6 plátano |
| Financiación | Financiable por SNS según material | Confirmar nomenclátor vigente |

## 11.2 Evidencia Kansu et al., Acta Paediatrica 2018

| Campo | Detalle |
|---|---|
| Diseño | Estudio clínico de 6 meses en niños desnutridos con fallo de crecimiento. |
| Exposición | 94% recibió PediaSure Fibre o PediaSure Plus Fibre. |
| Peso/edad Z | De -2,12 basal a -1,71 meses 2-3 y -1,51 meses 4-6; +0,41 y +0,61; p<0,001; material lo expresa como aumento del 40%. |
| Apetito | Aumento reportado por 63,4% en meses 2-3 y 77,9% en meses 4-6; p<0,001. |
| Síntomas GI | Vómitos -57% p=0,009; náuseas -68% p=0,001; distensión -63% p<0,001; estreñimiento -78% p=0,004. |
| Cautela | No todos recibieron exactamente Plus Fiber; resultados frente a basal y sin comparador explícito en el CLM. |

## 11.3 Evidencia en parálisis cerebral

**Resultado:** Aumento del 4,7% de masa magra en 3 meses en n=15 con PediaSure Plus Fiber, comparando final con basal.

**Cautela:** Muestra muy pequeña y población específica. No generalizar a todos los niños con desnutrición.

## 11.4 Preguntas de visita

- ¿Qué síntomas limitan más la pauta: estreñimiento, distensión, náuseas o vómitos?
- ¿En qué pacientes mantiene una fórmula polimérica con fibra antes de escalar a una peptídica?
- ¿Qué indicador utiliza para evaluar respuesta: Z-score, apetito, masa magra o tolerancia?

# 12. PediaSure Peptide y Vital Peptido 1.5

## 12.1 Racional de fórmula peptídica

- El material asocia las fórmulas peptídicas con mejor tolerancia y absorción, equilibrio nitrogenado, ganancia de peso, absorción de grasa e integridad intestinal.
- También comunica reducción de diarrea, interrupciones de alimentación, distensión, vómitos y hematemesis en niños con función GI comprometida.
- Una revisión/consenso de 19 estudios, 12 clínicos y 7 revisiones, propone considerarlas como primera línea para tolerancia GI, diarrea/inflamación y crecimiento. Esta recomendación debe contextualizarse por población y calidad de la evidencia.

## 12.2 PediaSure Peptide

| Característica | Dato |
|---|---|
| Proteína | 6 g por 200 ml; 100% hidrolizada; 30% caseinato hidrolizado según comparativa |
| MCT | 50% del total de grasa |
| Osmolaridad | 272 mOsm/L; el material la presenta como la más baja del subtipo comparado |
| Densidad | 1 kcal/ml |
| Fibra | Comparativa la presenta sin fibra |
| Financiación | Financiable por SNS según material |

## 12.3 TolerUP, Frontiers in Pediatrics 2025

| Campo | Detalle |
|---|---|
| Población | Niños con parálisis cerebral y problemas previos de tolerancia a fórmula enteral estándar; alimentación por sonda. |
| Diseño | Prospectivo observacional; seguimiento 6 meses; comparación basal vs 1 mes; aproximadamente 91% recibió PediaSure Peptide. |
| Síntomas diarios a 1 mes | Malestar -73%; distensión -75%; náuseas -70%; vómitos -60%; producción de gas -50%; todos p<0,001 según material. |
| Antropometría | Mejoría significativa comunicada, pero el texto extraído no contiene magnitudes. |
| Cautela | No aleatorizado, mayoría pero no 100% con producto, población neurológica y con intolerancia previa. |

## 12.4 Comparativa peptídica

| Producto | Proteína | MCT | Densidad/osmolaridad | Orientación |
|---|---|---|---|---|
| PediaSure Peptide | 6 g/200 ml; 100% hidrolizada | 50% | 1 kcal/ml; 272 mOsm/L | Pediatría, intolerancia GI y sonda |
| Vital Peptido 1.5 | 13 g/200 ml; 70% hidrolizado de suero | 70% | 1,5 kcal/ml; osmolaridad no visible en extracción | Mayor densidad/proteína y necesidad peptídica |

**Aceptación Vital:** El material comunica mejor aceptación que otros SNO peptídicos, basada en una prueba de sabor a ciegas publicada por Guardia-Baena, Nutrición Hospitalaria 2025;42(5):885-893.

**Formatos Vital:** Caja de 30 botellas: 18 vainilla, 6 frutas del bosque y 6 café; financiable por SNS según material.

# 13. Similac High Energy

**Posicionamiento:** Fórmula completa polimérica para lactantes con necesidades energéticas elevadas, presentada especialmente para cardiopatía congénita, prematuridad y recuperación del crecimiento.

**AVISO OBLIGATORIO**
La leche materna es el mejor alimento para el lactante y se recomienda durante el mayor tiempo posible. Mantener este aviso en cualquier conversación basada en el material.

## 13.1 Necesidad clínica

- 31% de la población pediátrica hospitalizada presenta malnutrición en el estudio DHOSPE citado.
- 43% de pacientes con cardiopatías graves presentaron malnutrición en el primer año según la referencia de Mignot et al.
- El riesgo de malnutrición es mayor en menores de 2 años.
- En prematuros moderados y tardíos, la necesidad de soporte activo aumenta al disminuir la edad gestacional.

## 13.2 Características del producto

| Característica | Dato | Cautela |
|---|---|---|
| Formato | 30 botellas de 200 ml; sabor neutro; código 505065 | Financiable por SNS según material |
| Densidad | 1 kcal/ml | Las fórmulas altas en calorías se proponen cuando se necesita más energía |
| Tipo de proteína | Fórmula polimérica | Evidencia de mayor utilización frente a hidrolizadas proviene de prematuros y revisiones |
| Azúcar | 5,5 g/100 ml; sin glucosa en lista de ingredientes | Comparativa frente a Infatrini 5,9 e Infatrini Powder 6,3, nomenclátor agosto 2026 |
| Osmolaridad | 299 mOsm/L | Comparativa del material: Infatrini 305 e Infatrini Powder 340 |
| Grasa | Sin aceite de palma en el comparador definido | No extrapolar todos los datos de oleína de palma a outcomes del producto |
| MCT | 14% aproximado | Racional para energía y absorción; no es un outcome clínico por sí solo |

## 13.3 Evidencia/racional

- Fórmulas de 1 kcal/ml pueden apoyar recuperación de crecimiento en lactantes con cardiopatía congénita, antecedente de prematuridad o estancia prolongada en UCIP.
- En una revisión Cochrane en prematuros, las fórmulas poliméricas mostraron utilización proteica más eficiente y se cita necesidad de aumentar 10% la proteína en hidrolizadas para compensar menor utilización. Confirmar aplicabilidad antes de usar.
- La ausencia de oleína de palma se relaciona en estudios con mejor absorción de grasa/calcio, mineralización y heces más blandas, pero gran parte es evidencia de formulación/ingrediente.

## 13.4 Preguntas de visita

- ¿Qué lactantes no alcanzan requerimientos con volumen estándar?
- ¿Qué limita más la tolerancia: osmolaridad, volumen, grasa o proteína?
- ¿En cardiopatía congénita, cuándo decide concentrar energía y cómo monitoriza el crecimiento?
- ¿Qué peso da a azúcar, osmolaridad y tipo de grasa en la elección?

# 14. Nepro: nutrición específica renal

**Posicionamiento:** Gama específicamente diseñada para diferentes estadios de ERC, con versiones LP para no dializados y HP para dializados, dentro de un algoritmo de cribado, diagnóstico e intervención del desgaste proteico-energético.

## 14.1 Algoritmo por estadio

| Situación | Objetivo energético/proteico | Intervención del material |
|---|---|---|
| ERC 1-2 no dializado; FG >60 | 30-35 kcal/kg/d; proteína según población general | Recomendaciones + SNO HC/HP con HMB |
| ERC 3-5 no dializado; FG <60 | 30-35 kcal/kg/d; 0,7-0,8 g proteína/kg/d | SNO renal HC/hipoproteico: Nepro Gold LP |
| ERC 5D, hemodiálisis; FG <15 | 30-35 kcal/kg/d; 1-1,2 g proteína/kg/d | SNO renal HC/alto en proteína: Nepro Gold HP / HP |
| Diálisis peritoneal | 1-1,2 g proteína/kg/d | SNO renal HC/alto en proteína |
| Hospitalizado con ingesta >20 kcal/kg/d o >50% requisitos | Recomendaciones + SNO | Mantener al menos 3 meses |
| Hospitalizado con ingesta <20 kcal/kg/d o <50% requisitos | Evaluar tracto GI | Si funciona, NE por sonda; si no, NP; en mala tolerancia considerar NPID |

## 14.2 Gama y formatos

| Producto | Formato/sabor/código | Datos clave |
|---|---|---|
| Nepro Gold LP | 30 x 220 ml; vainilla 506516, fresa 506517, multisabor 506515 | ERC no dializado; HC/hipoproteico; fibra 3,92 g/botella |
| Nepro Gold HP | 30 x 220 ml; vainilla 505339 | Dializado; HC/alto en proteína; fibra 4,05 g/botella |
| Nepro HP | 8 x 500 ml; vainilla 506495 | Formato alto en proteína; revisar modalidad de uso |

- Todos se presentan sin gluten, aptos para intolerantes a la lactosa, no aptos para galactosémicos y financiables por SNS.
- Proteínas de alto valor biológico y ratio fósforo/proteína <16 según material.
- Aptos para paciente diabético según material.

## 14.3 Fibra y eje intestino-riñón

| Producto | Fibra soluble / insoluble | Mensajes del material |
|---|---|---|
| Nepro Gold LP | FOS 50,19% / insoluble 49,81% | Excreción intestinal de potasio, tránsito, barrera intestinal, inflamación y toxinas urémicas |
| Nepro Gold HP | FOS 46,26% / insoluble 53,74% | Mismos ejes fisiológicos, composición adaptada |

**Cautela:** Los mensajes de menor mortalidad, recuperación nutricional o toxinas urémicas proceden de guías, tablas de ratio y revisiones sobre fibra/CKD. No atribuir automáticamente cada outcome a la fórmula sin revisar la referencia exacta.

## 14.4 Preguntas para Nefrología/Nutrición

- ¿Cómo detectan DPE y qué herramienta utilizan en ERC?
- ¿Cómo adaptan proteína entre ERC 3-5 no dializada y diálisis?
- ¿Qué barreras limitan 3 meses de SNO: volumen, potasio, fósforo, glucemia o tolerancia?
- ¿Qué relevancia tiene el ratio fósforo/proteína en la selección?
- ¿Utilizan fibra como parte del abordaje del eje intestino-riñón?

# 15. Matriz ESP por especialidad

| Especialidad | Producto/eje | Pregunta de apertura | Evidencia/material |
|---|---|---|---|
| Gastroenterología pediátrica | Plus Fiber vs Peptide | ¿Qué síntoma o causa le hace escalar de una fórmula polimérica con fibra a una peptídica? | Kansu 2018; TolerUP 2025 |
| Neuropediatría | PediaSure Peptide | ¿Qué problemas de tolerancia por sonda ve con más frecuencia en parálisis cerebral? | TolerUP: síntomas a 1 mes |
| Pediatría hospitalaria | Plus Fiber / Similac HE | ¿Qué pacientes pierden crecimiento durante el ingreso y qué limita el volumen? | DHOSPE; crecimiento y tolerancia |
| Cardiología pediátrica | Similac High Energy | ¿Cómo cubren requerimientos elevados sin aumentar excesivamente volumen/carga? | 1 kcal/ml, cardiopatía congénita |
| Neonatología | Similac High Energy | ¿Qué prematuros tardíos requieren soporte activo tras el alta? | ESPGHAN prematuro; fórmula alta energía |
| Nutrición pediátrica | Mapa completo | ¿Qué algoritmo usa entre polimérica con fibra y peptídica? | Composición, osmolaridad y outcomes |
| Nefrología | Nepro LP/HP | ¿Cómo cambia el objetivo proteico cuando pasa de ERC no dializada a diálisis? | Algoritmo KDOQI/ESPEN |
| Nutrición de adultos renal | Nepro | ¿Qué pacientes con ERC y DPE mantienen ingesta <50% de requerimientos? | Algoritmo y 3 meses de SNO |
| Farmacia hospitalaria | Todos ESP | ¿Qué criterio de protocolo pesa más: densidad, osmolaridad, proteína, ratio fósforo/proteína o financiación? | Ficha y nomenclátor de cada producto |

# 16. Claims y cautelas ESP

| Claim/mensaje | Producto | Contexto obligatorio | Evitar |
|---|---|---|---|
| Reduce hasta 78% síntomas GI | PediaSure Plus Fiber | Estudio 6 meses; 94% recibió Fibre/Plus Fibre; síntoma concreto | Decir 78% para todos los síntomas |
| Aumenta 40% Z-score peso/edad | PediaSure Plus Fiber | Cambio de -2,12 a -1,51; lenguaje del CLM | Interpretarlo como 40% de peso |
| Síntomas diarios disminuyen en 1 mes | PediaSure Peptide | TolerUP, PC, sonda, intolerancia previa, 91% con producto | Generalizar a cualquier niño |
| Osmolaridad más baja 272 | PediaSure Peptide | Comparadores/subtipo y fecha agosto 2026 | Convertir en superioridad clínica automática |
| Azúcar y osmolaridad más bajas | Similac HE | Comparación con Infatrini/Infatrini Powder, nomenclátor agosto 2026 | Generalizar a todo mercado |
| Única sin aceite de palma | Similac HE | Comparador definido en subtipo CPNN5 | Omitir comparador/fecha |
| Fórmula renal en ERC 3-5 | Nepro | Estadio, diálisis y objetivo proteico | Usar HP en no dializado sin justificar |
| Menor riesgo de mortalidad | Nepro/racional renal | Referencia y relación exacta no claras en folleto | Atribuir causalidad al producto |

# 17. Trazabilidad de esta actualización

| Documento | Páginas | Productos |
|---|---|---|
| PediaSure - CLM Paciente con síntomas GI | 30 | PediaSure Plus Fiber, PediaSure Peptide, Vital Peptido 1.5 |
| Similac High Energy CLM | 18 | Similac High Energy |
| NEPRO - Información Clave | 2 | Nepro Gold LP, Gold HP y HP 500 ml |

**ESTADO**
La guía combina ahora HMB y ESP. Para el agente, deben mantenerse rutas separadas: HMB = Ensure/Glucerna; ESP = PediaSure/Similac/Vital/Nepro. La recomendación final debe depender del tipo de delegado, población, necesidad clínica y evidencia concreta disponible.

# 18. Vital Peptido 1.5: ampliación clínica y operativa

**NUEVOS MATERIALES INTEGRADOS**
Caso clínico en cáncer de páncreas con malabsorción postquirúrgica, caso clínico en enfermedad de Crohn y díptico para profesionales no expertos con algoritmo de cribado y diagnóstico nutricional.

## 18.1 Perfil completo del producto

| Dimensión | Información consolidada | Uso para el delegado |
|---|---|---|
| Tipo de producto | Dieta específica, equilibrada y completa; hipercalórica, hiperproteica y con 100% de proteínas hidrolizadas | Presentar a partir de una necesidad de malabsorción o mala tolerancia, no solo por desnutrición |
| Edad | A partir de 4 años según díptico | Verificar edad y población antes de recomendar |
| Densidad | 1,5 kcal/ml | Útil cuando se necesita concentrar energía |
| Aporte 200 ml | 300 kcal y 13,60 g de proteína | Cuantificar aporte por botella |
| Aporte 1.000 ml | 1.501 kcal y 68 g de proteína | Formato para administración por sonda |
| Proteína | 100% hidrolizada: 70% seroproteína hidrolizada y 30% caseinato hidrolizado | Racional de digestibilidad y liberación sostenida de aminoácidos |
| Grasa | 70% MCT del total de grasas | Fuente lipídica de absorción más sencilla en malabsorción |
| Perfil lipídico | Ratio omega-3/omega-6 1:2,2, descrito como perfil antiinflamatorio | Usar como característica de composición, no prometer un outcome antiinflamatorio |
| Fibra | Sin fibra | Valorar si el paciente necesita fibra o si puede ser inconveniente |
| Tolerancias | Sin gluten; apto para intolerantes a la lactosa; no apto para galactosémicos | Comprobar alergias/intolerancias y diagnóstico |
| Financiación | Financiable por SNS según material | Confirmar nomenclátor vigente y circuito autonómico |

## 18.2 Formatos, sabores y códigos

| Formato | Sabor | Código | Observación |
|---|---|---|---|
| 30 botellas de 200 ml | Vainilla | 505081 | Uso oral |
| 30 botellas de 200 ml | Café | 505083 | Preferido por 81% en prueba ciega citada |
| 30 botellas de 200 ml | Frutas del bosque | 505082 | Uso oral |
| 30 botellas de 200 ml | Multisabor | 505084 | 18 vainilla, 6 frutas del bosque y 6 café |
| 8 botellas de 1.000 ml | Vainilla | 505080 | Administración por sonda |

**Aceptación:** La prueba de sabor a ciegas comunicada indica preferencia del 81% para café y 69% para vainilla frente a otros SNO peptídicos. Es una medida de preferencia sensorial, no de adherencia clínica sostenida.

# 19. Algoritmo de detección del paciente candidato

## 19.1 Punto de entrada: MUST

| Paso | Criterio | Puntuación / actuación |
|---|---|---|
| 1. IMC | >20; 18,5-20; <18,5 kg/m$^2$ | 0; 1; 2 puntos |
| 2. Pérdida de peso 3-6 meses | <5%; 5-10%; >10% | 0; 1; 2 puntos |
| 3. Efecto de enfermedad aguda | Muy enfermo y sin aporte, o previsión de ausencia de aporte >5 días | 2 puntos |
| 4. Riesgo global | Suma de pasos 1-3 | 0 bajo; 1 intermedio; ≥2 alto |
| 5. Tratamiento | Riesgo alto | Tratar, derivar/aplicar protocolo, fijar objetivos, aumentar aporte y monitorizar |

## 19.2 Frecuencia de repetición MUST

| Entorno | Riesgo bajo | Riesgo intermedio / alto |
|---|---|---|
| Hospital | Semanal | Todas las semanas |
| Residencia | Mensual | Todos los meses |
| Comunidad/domicilio | Anual si bajo; cada 2-3 meses si intermedio | Mensual si alto |

## 19.3 Diagnóstico GLIM

**REGLA GLIM**
Diagnóstico de desnutrición cuando existe al menos un criterio fenotípico y al menos un criterio etiológico.

| Tipo | Criterio | Umbral / definición |
|---|---|---|
| Fenotípico | Pérdida involuntaria de peso | >5% en 6 meses o >10% en más de 6 meses |
| Fenotípico | Bajo IMC | <20 kg/m$^2$ si <70 años; <22 kg/m$^2$ si ≥70 años |
| Fenotípico | Masa muscular reducida | ASMI <7 varón/<6 mujer; FFMI <17 varón/<15 mujer; ALM <21,4 varón/<14,1 mujer |
| Etiológico | Ingesta/absorción reducida | ≤50% de requerimientos >1 semana; cualquier reducción >2 semanas; trastorno GI crónico con impacto nutricional |
| Etiológico | Inflamación | Enfermedad aguda o crónica con inflamación sistémica grave |

## 19.4 Gravedad GLIM

| Parámetro | Moderada | Grave |
|---|---|---|
| Pérdida de peso | 5-10% en últimos 6 meses o 10-20% en >6 meses | >10% en últimos 6 meses o >20% en >6 meses |
| IMC <70 años | <20 kg/m$^2$ | <18,5 kg/m$^2$ |
| IMC ≥70 años | <22 kg/m$^2$ | <20 kg/m$^2$ |
| Masa muscular | Pérdida leve-moderada | Pérdida grave |

**Medición muscular:** GLIM admite DEXA, BIA, ultrasonidos, CT o RMN; también perímetro de pantorrilla/brazo junto con fuerza de prensión como aproximaciones clínicas.

## 19.5 Sugerencias de uso del material

- Enfermedad inflamatoria intestinal: Crohn y colitis ulcerosa.
- Pancreatitis e insuficiencia pancreática/malabsorción postquirúrgica.
- Fibrosis quística.
- Síndrome de intestino corto.
- Patología hepatobiliar.
- Disfunción de la mucosa intestinal.
- Postoperatorio.
- Paciente oncológico con malabsorción o mala tolerancia.

**REGLA DE RECOMENDACIÓN**
La secuencia correcta para el agente es: riesgo nutricional → diagnóstico GLIM → presencia de malabsorción o mala tolerancia →

necesidad de fórmula peptídica hipercalórica/hiperproteica → selección del formato oral o sonda.

# 20. Caso clínico: cáncer de páncreas y malabsorción postquirúrgica

| Elemento | Detalle |
|---|---|
| Perfil | Paciente de 54 años con adenocarcinoma de páncreas y pancreatectomía total. |
| Complicaciones | Insuficiencia pancreática exocrina, diabetes secundaria, malabsorción y desnutrición grave; IMC 17,2 y pérdida ponderal del 11%. |
| Intervención integral | Dieta adaptada y fraccionada, terapia enzimática sustitutiva, Vital Peptido 1.5 hipercalórico/hiperproteico y control metabólico intensivo. |
| Peso | 46,3 kg a 50,9 kg; incremento de 4,6 kg. |
| Composición corporal | El material comunica +4,6 kg de masa magra y +1,5 kg de masa grasa. Estas cifras son incompatibles entre sí y con el cambio de peso total; verificar el original clínico antes de verbalizarlas. |
| Función | Dinamometría de 14 a 16 kg. |
| Analítica | Mejora de albúmina, prealbúmina y HbA1c, sin cifras en el material. |
| Tolerancia | Mejor tolerancia digestiva y síntomas. |
| Autoría | Caso difundido por Abbott; Abbott declara no haber participado en su realización. |

## 20.1 Lectura estratégica

- Caso útil para Digestivo, Endocrinología/Nutrición, Cirugía pancreática y Oncología cuando coinciden pancreatectomía, insuficiencia pancreática exocrina, diabetes secundaria y malabsorción.
- El resultado pertenece a una intervención integral. No atribuir el cambio exclusivamente a Vital Peptido 1.5.
- La cifra de composición corporal requiere validación por inconsistencia aritmética.
- El mejor uso es como caso de conversación y selección de paciente, no como prueba comparativa de eficacia.

## 20.2 Preguntas de apertura

- Tras una pancreatectomía total, ¿qué indicador le ayuda más a ajustar enzimas y soporte nutricional?
- ¿Cuándo considera una fórmula peptídica frente a una polimérica en insuficiencia pancreática exocrina?
- ¿Cómo equilibra recuperación ponderal, control glucémico y tolerancia digestiva?

# 21. Caso clínico: enfermedad de Crohn y desnutrición

| Elemento | Detalle |
|---|---|
| Perfil | Paciente de 75 años con Crohn ileal estenosante, resección ileocecal y antecedente de cáncer de próstata en tratamiento. |
| Situación basal | Diarrea crónica de 5-6 deposiciones/día por malabsorción de ácidos biliares; debilidad; pérdida de peso del 14% en 6 meses, de 63 a 54 kg; IMC 19,7; riesgo alto de desnutrición y sarcopenia. |
| Intervención | Dieta astringente hipercalórica e hiperproteica de 1.400 kcal y 70 g proteína/día, Vital Peptido 1.5 dos envases/día durante 6 meses y ejercicio de fuerza. |
| Peso comunicado | El material indica +5 kg, pero muestra 54 kg a 62 kg, que equivaldría a +8 kg. Inconsistencia que debe verificarse. |
| IMC | Mejora hasta 21,4 $kg/m^2$. |
| Masa muscular | Perímetro de pantorrilla de 32 a 34 cm. |
| Función | Mejora del estado general y funcional, sin escala cuantitativa. |
| Autoría | Caso difundido por Abbott; Abbott declara no haber participado en su realización. |

## 21.1 Lectura estratégica

- Caso relevante para EII con resección ileocecal, diarrea por malabsorción biliar, pérdida ponderal y sarcopenia.
- La intervención combina dieta, dos envases diarios, seis meses y ejercicio de fuerza. No aislar el efecto del producto.
- El perímetro de pantorrilla aporta una medida clínica sencilla, pero puede verse afectado por hidratación y no sustituye técnicas validadas.
- No usar la expresión “revertir la desnutrición” sin aclarar que se trata de un único caso clínico.

## 21.2 Preguntas de apertura

- En Crohn resecado con diarrea crónica, ¿qué determina la elección entre polimérica y peptídica?
- ¿Cómo monitoriza recuperación muscular: pantorrilla, fuerza, BIA o ecografía?
- ¿Qué duración mínima considera necesaria para valorar respuesta en malabsorción crónica?

# 22. Evidencia, mensajes y límites de Vital Peptido 1.5

| Mensaje | Fuente/contexto | Cómo expresarlo | No decir |
|---|---|---|---|
| Mejora síntomas GI | López-Medina et al., Nutrition 2022;102:111734, pacientes con alteración GI y SNO peptídico | En el estudio citado, la adherencia al tratamiento se relacionó con mejora nutricional y de síntomas | Que garantiza tolerancia en todos los pacientes |
| Mejor aceptación | Prueba ciega de sabor; café 81%, vainilla 69% | Preferencia sensorial en la prueba comparativa citada | Que tiene mayor adherencia clínica |
| Liberación sostenida/anabolismo | Mezcla 70% suero y 30% caseinato; racional de Paul et al. | La mezcla se diseñó para combinar cinéticas proteicas | Que ha demostrado más masa muscular en EII/cáncer por sí sola |
| 70% MCT | Característica de la fórmula | Puede ser relevante cuando existe malabsorción de grasas | Que los MCT corrigen cualquier malabsorción |
| Perfil antiinflamatorio 1:2,2 | Racional omega-3/omega-6 | Característica del perfil lipídico | Que trata la inflamación de Crohn o cáncer |
| Casos clínicos | Dos casos, intervención multimodal | Ejemplos de utilización en perfiles complejos | Evidencia causal o comparativa |

## 22.1 Diferenciación práctica frente a otros productos de la guía

| Escenario | Producto a explorar | Razón |
|---|---|---|
| Adulto ≥4 años con malabsorción/mala tolerancia y alta necesidad energética/proteica | Vital Peptido 1.5 | 1,5 kcal/ml, 13,6 g proteína/200 ml, 100% hidrolizada y 70% MCT |
| Niño con intolerancia a polimérica y necesidad 1 kcal/ml | PediaSure Peptide | Perfil pediátrico, 6 g proteína/200 ml, 50% MCT, 272 mOsm/L |
| Niño desnutrido con síntomas GI que tolera proteína entera y se beneficia de fibra | PediaSure Plus Fiber | Fórmula polimérica con 2,42 g de fibra por 220 ml |
| Adulto con DRE sin malabsorción como eje dominante | Ensure Plus Advance | Evidencia HMB, músculo, función y postalta |
| Adulto con diabetes + DRE sin malabsorción como eje dominante | Glucerna Advance 1.6 | Control metabólico y recuperación muscular específica en diabetes |

## 22.2 Qué registrar en CRM tras una visita Vital

- Diagnóstico y causa de malabsorción/mala tolerancia.
- Cribado MUST y criterios GLIM presentes.
- Pérdida de peso, IMC, masa muscular y función.
- Síntomas GI y frecuencia: diarrea, vómitos, distensión, dolor, esteatorrea.
- Vía oral o sonda, volumen tolerado y necesidad calórica/proteica.
- Uso de enzimas pancreáticas, tratamiento de malabsorción biliar u otras medidas concomitantes.
- Producto previo, causa de fracaso y duración.
- Outcome acordado y fecha de revisión.

# 23. Trazabilidad de la actualización Vital

| Documento | Páginas | Aportación principal |
|---|---|---|
| VITAL - CASO CLÍNICO ONCOLÓGICO | 2 | Pancreatectomía total, malabsorción, intervención multimodal y ficha completa de producto |
| VITAL - DÍPTICO NO EXPERTOS | 2 | Composición, formatos, MUST, GLIM, patologías y algoritmo nutricional |
| VITAL - CASO CLÍNICO EII | 2 | Crohn resecado, diarrea, desnutrición/sarcopenia y seguimiento a 6 meses |

**CONTROL DE CALIDAD**
Se han conservado dos inconsistencias detectadas en los casos: masa magra/grasa frente al cambio total de peso en el caso pancreático, y +5 kg frente a 54→62 kg en el caso de Crohn. El agente debe evitar esas cifras hasta que Marketing o Medical confirme el dato correcto.